

Enquadramento:

No decorrer da sua atividade enquanto NS, na **praia do Cabedelo**, é alertado para a presença de uma vítima, um **homem com aproximadamente 40 anos**, que se **encontrou em dificuldades na água e que está a ser resgatado por populares que o colocam no areal**.

Como procederia?

Definir o algoritmo	Algoritmo SBV Afogamento
Avaliar condições de segurança	Avalia e garante condições de segurança
Avaliar o estado de consciência (<u>NÃO RESPONDE</u>)	- Avalia o estado de consciência - Estímulo verbal; - Estímulo tátil bilateral.
Permeabilização da Via Aérea	- Extensão da cabeça - Elevação da mandíbula
Teste de VOS (<u>NÃO VENTILA</u>)	- Posiciona-se corretamente; - Ver movimentos torácico-abdominais; - Ouvir o ruído do ar a entrar nas vias aéreas; - Sentir o ar expirado da vítima; - Até 10 segundos.
Não ventila / Liga 112	- Onde se encontra (localização exata) - Quem é a vítima (género e faixa etária) - O quê (o que aconteceu e estado da vítima) - Como (sabe fazer SBV e vai iniciar manobras)
Não ventila	5 insuflações com O2 se possível; - Observa sinais de vida (tosse, movimento, resp. normal).
Inicia manobras (RCP) (<u>REALIZAR 2 A 4 CICLOS DE RCP ATÉ A VÍTIMA REAGIR</u>)	- Colocação correta perante a vítima; - Coloca as mãos corretamente (centro do tórax); - Número de CTE/Insuflações (30:2); - CTE (5/6 cm; 100/120 min; tempo compressão = descompressão); - Insuflações eficazes (sem fugas, expansão visível do tórax); - Sinal de reação vítima (interrompe manobras e VOS); - Coloca vítima em PLS (objetivo permeabilização da VA).

Enquadramento:

Após a vítima recuperar, ventilando normalmente, chega o seu colega com o Kit de Oxigénio Terapia.

Proceda à administração de O2.

Definir o método de administração de O2	Inalação.
Montagem do material e cuidados em relação à vítima	- Monta o regulador de pressão; - Liga tubo conector; - Máscara de alta concentração (composta/alto débito); - Abre a garrafa; - Seleciona o débito (15 L/min.); - Coloca a máscara à vítima (acalma e informa a vítima).
Desmontagem do material e manutenção	- Descarta o material utilizado (máscara e tubo); - Fecha a garrafa e descarrega o sistema.

Enquadramento:

No decorrer da sua atividade enquanto NS, na **praia Norte**, é alertado para a presença de uma vítima, uma **mulher com aproximadamente 55 anos**, que se **encontra inanimada**.

Como procederia?

Definir o algoritmo	Algoritmo SBV
Avaliar condições de segurança	Avalia e garante condições de segurança
Avaliar o estado de consciência (NÃO RESPONDE)	- Avalia o estado de consciência - Estímulo verbal; - Estímulo tátil bilateral.
Permeabilização da Via Aérea	- Extensão da cabeça - Elevação da mandíbula
Teste de VOS (NÃO VENTILA)	- Posiciona-se corretamente; - Ver movimentos torácico-abdominais; - Ouvir o ruído do ar a entrar nas vias aéreas; - Sentir o ar expirado da vítima; - Até 10 segundos.
Não ventila / Liga 112	- Onde se encontra (localização exata) - Quem é a vítima (género e faixa etária) - O quê (o que aconteceu e estado da vítima) - Como (sabe fazer SBV e vai iniciar manobras)
Inicia manobras (RCP) (REALIZAR 2 A 4 CICLOS DE RCP ATÉ A VÍTIMA REAGIR)	- Colocação correta perante a vítima; - Coloca as mãos corretamente (centro do tórax); - Número de CTE/Insuflações (30:2); - CTE (5/6 cm; 100/120 min; tempo compressão = descompressão); - Insuflações eficazes (sem fugas, expansão visível do tórax); - Sinal de reação vítima (interrompe manobras e VOS); - Coloca vítima em PLS (objetivo permeabilização da VA).

Enquadramento:

Após a vítima recuperar, ventilando normalmente, chega o seu colega com o Kit de Oxigénio Terapia.

Proceda à administração de O2.

Definir o método de administração de O2	Inalação.
Montagem do material e cuidados em relação à vítima	- Monta o regulador de pressão; - Liga tubo conector; - Máscara de alta concentração (composta/alto débito); - Abre a garrafa; - Seleciona o débito (15 L/min.); - Coloca a máscara à vítima (acalma e informa a vítima).
Desmontagem do material e manutenção	- Descarta o material utilizado (máscara e tubo); - Fecha a garrafa e descarrega o sistema.

Enquadramento:

No decorrer da sua atividade enquanto NS, na **praia de Paçô**, é alertado para a presença de uma vítima, um **rapaz com aproximadamente 8 anos**, que se **encontrou em dificuldades na água e que está a ser resgatado por populares que o colocam no areal**.

Como procederia?

Definir o algoritmo	Algoritmo SBV Afogamento
Avaliar condições de segurança	Avalia e garante condições de segurança
Avaliar o estado de consciência (NÃO RESPONDE)	- Avalia o estado de consciência - Estímulo verbal; - Estímulo tátil bilateral.
Permeabilização da Via Aérea	- Extensão da cabeça - Elevação da mandíbula
Teste de VOS (NÃO VENTILA)	- Posiciona-se corretamente; - Ver movimentos torácico-abdominais; - Ouvir o ruído do ar a entrar nas vias aéreas; - Sentir o ar expirado da vítima; - Até 10 segundos.
Não ventila / Liga 112	- Onde se encontra (localização exata) - Quem é a vítima (género e faixa etária) - O quê (o que aconteceu e estado da vítima) - Como (sabe fazer SBV e vai iniciar manobras)
Não ventila	5 insuflações com O2 se possível; Inverte a máscara (criança) - Observa sinais de vida (tosse, movimento, resp. normal).
Inicia manobras (RCP) (REALIZAR 3 A 6 CICLOS DE RCP ATÉ A VÍTIMA REAGIR)	- Colocação correta perante a vítima; - Coloca as mãos corretamente (centro do tórax); Número de CTE/Insuflações (15:2); - CTE (1/3 depressão ($\approx$ 5 cm); 100/120 min; tempo compressão = descompressão); - Insuflações eficazes (sem fugas, expansão visível do tórax); - Sinal de reação vítima (interrompe manobras e VOS); - Coloca vítima em PLS (objetivo permeabilização da VA).

Enquadramento:

Após a vítima recuperar, ventilando normalmente, chega o seu colega com o Kit de Oxigénio Terapia.

Proceda à administração de O2.

Definir o método de administração de O2	Inalação.
Montagem do material e cuidados em relação à vítima	- Monta o regulador de pressão; - Liga tubo conector; - Máscara de alta concentração (composta/alto débito) – tamanho pediátrico; - Abre a garrafa; - Seleciona o débito (10 L/min.); - Coloca a máscara à vítima (acalma e informa a vítima).
Desmontagem do material e manutenção	- Descarta o material utilizado (máscara e tubo); - Fecha a garrafa e descarrega o sistema.

Enquadramento:

No decorrer da sua atividade enquanto NS, na **praia de Afife**, é alertado para a presença de uma vítima, uma **rapariga com aproximadamente 6 anos**, que se **encontra inanimada**.

Como procederia?

Definir o algoritmo	Algoritmo SBV Pediátrico
Avaliar condições de segurança	Avalia e garante condições de segurança
Avaliar o estado de consciência (<u>NÃO RESPONDE</u>)	- Avalia o estado de consciência - Estímulo verbal; - Estímulo tátil bilateral. - Grita por ajuda
Permeabilização da Via Aérea	- Extensão da cabeça - Elevação da mandíbula
Teste de VOS (<u>NÃO VENTILA</u>)	- Posiciona-se corretamente; - Ver movimentos torácico-abdominais; - Ouvir o ruído do ar a entrar nas vias aéreas; - Sentir o ar expirado da vítima; - Até 10 segundos.
Não ventila	5 insuflações; Inverte a máscara (criança) - Observa sinais de vida (tosse, movimento, resp. normal).
Inicia manobras (RCP) (<u>REALIZAR 5 CICLOS DE RCP</u>)	- Colocação correta perante a vítima; - Inicia 1 minuto de RCP (5 ciclos 15:2) - Coloca as mãos corretamente (centro do tórax); Número de CTE/Insuflações (15:2); - CTE (1/3 depressão ($\approx$ 5 cm); 100/120 min; tempo compressão = descompressão); - Insuflações eficazes (sem fugas, expansão visível do tórax);
Não ventila APÓS 5 CLICLO DE RCP / Liga 112	- Onde se encontra (localização exata) - Quem é a vítima (género e faixa etária) - O quê (o que aconteceu e estado da vítima) - Como (sabe fazer SBV e vai iniciar manobras)
Inicia manobras (RCP) (<u>REALIZAR 3 A 6 CICLOS DE RCP ATÉ A VÍTIMA REAGIR</u>)	- Colocação correta perante a vítima; - Coloca as mãos corretamente (centro do tórax); Número de CTE/Insuflações (15:2); - CTE (1/3 depressão ($\approx$ 5 cm); 100/120 min; tempo compressão = descompressão); - Insuflações eficazes (sem fugas, expansão visível do tórax); - Sinal de reação vítima (interrompe manobras e VOS); - Coloca vítima em PLS (objetivo permeabilização da VA).

Enquadramento:

Após a vítima recuperar, ventilando normalmente, chega o seu colega com o Kit de Oxigénio Terapia.

Proceda à administração de O2.

Definir o método de administração de O2	• Inalação.
Montagem do material e cuidados em relação à vítima	• Monta o regulador de pressão; • Liga tubo conector; • Máscara de alta concentração (composta/alto débito) – tamanho pediátrico; • Abre a garrafa; • Selecciona o débito (10 L/min.); • Coloca a máscara à vítima (acalma e informa a vítima).
Desmontagem do material e manutenção	• Descarta o material utilizado (máscara e tubo); • Fecha a garrafa e descarrega o sistema.

Enquadramento:

No decorrer da sua atividade enquanto NS, na **praia da Arda**, é alertado para a presença de **uma grávida com aproximadamente 35 anos**, que se **encontra com dificuldades respiratórias e reflexo de tosse, no decorrer de se ter engasgado**.

Como procederia?

Definir o algoritmo	Obstrução via aérea (OVA)
Avaliar condições de segurança	Avalia e garante condições de segurança
Manobra de desobstrução vítima grávida consciente <u>(DEFINIR O TIPO DE OBSTRUÇÃO DE ACORDO COM O ENQUADRAMENTO)</u>	- Ligeira - Incentiva a tossir e vigia - Grave - Inicia manobras de desobstrução - Aplica "pancadas inter-escapulares" (até 5) - Compressões abdominais substituídas por CTE - CTE - Colocação das mãos no tórax (grávida/obeso)
Vítima grávida inconsciente / Liga 112	- Onde se encontra (localização exata) - Quem é a vítima (género e faixa etária) - O quê (o que aconteceu e estado da vítima) - Como (sabe fazer SBV e vai iniciar manobras)
Inicia manobras (RCP) <u>(REALIZAR 2 A 4 CICLOS DE RCP ATÉ A VÍTIMA REAGIR)</u>	- Colocação correta perante a vítima; - Coloca as mãos corretamente (centro do tórax); - Número de CTE/Insuflações (30:2); - CTE (5/6 cm; 100/120 min; tempo compressão = descompressão); - Insuflações eficazes (sem fugas, expansão visível do tórax); - Sinal de reação vítima (interrompe manobras e VOS); - Coloca vítima em PLS (objetivo permeabilização da VA).

Enquadramento:

A vítima não recupera, chegando o seu colega com o Kit de Oxigénio Terapia, substituindo-o na realização do SBV. Proceda à administração de O2.

Definir o método de administração de O2	Insuflação.
Montagem do material e cuidados em relação à vítima	- Monta o regulador de pressão; - Liga tubo conector; - Insuflador manual (com balonete); - Abre a garrafa; - Seleciona o débito (15 L/min.); Permeabilização da Via Aérea: - Colocação do tubo orofaríngeo – na situação de ainda não ter sido colocado. - Seleção – medição da distância entre a altura dos incisivos e o ângulo da mandíbula; - Introduzir tubo na cav. oral em posição invertida, até passar palato duro, rodar 180º, e introduzir até faringe; - Retirar no caso de a vítima estar reativa; - Após a colocação efetuar VOS. - Faz selagem da máscara (efetua a insuflação com 1 mão)
Desmontagem do material e manutenção	- Descarta o material utilizado (máscara e tubo); - Fecha a garrafa e descarrega o sistema.

Enquadramento:

No decorrer da sua atividade enquanto NS, na **praia de Moledo**, é alertado para a presença de **uma bebé de 8 meses**, que se **encontra agitado, não respira, com os lábios e face cianosados, após se ter engasgado**.

Como procederia?

Definir o algoritmo	• Obstrução via aérea (OVA) - lactente
Avaliar condições de segurança	• Avalia e garante condições de segurança
Manobra de desobstrução vítima latente consciente <u>(DEFINIR TIPO DE OVA DE ACORDO COM O ENQUADRAMENTO)</u>	• Grave - Inicia manobras de desobstrução • Aplica "pancadas inter-escapulares" (até 5) • Aplica 5 compressões torácicas (até 5) • CTE - 2 dedos no torax do latente
Vítima latente inconsciente / Liga 112	• Onde se encontra (localização exata) • Quem é a vítima (género e faixa etária) • O quê (o que aconteceu e estado da vítima) • Como (sabe fazer SBV e vai iniciar manobras)
Inicia manobras (RCP) <u>(REALIZAR 3 A 6 CICLOS DE RCP ATÉ A VÍTIMA REAGIR)</u>	• Colocação correta perante a vítima; • Coloca as mãos corretamente (centro do tórax); • Número de CTE/Insuflações (15:2); • CTE (1/3 depressão (≈ 4 cm); 100/120 min; tempo compressão = descompressão); • Inverte a máscara (latente) • Insuflações eficazes (sem fugas, expansão visível do tórax); • Sinal de reação vítima (interrompe manobras e VOS); • Coloca vítima em PLS (objetivo permeabilização da VA).

Enquadramento:

A vítima não recupera, chegando o seu colega com o Kit de Oxigénio Terapia, substituindo-o na realização do SBV. Proceda à administração de O2.

Definir o método de administração de O2	• Insuflação.
Montagem do material e cuidados em relação à vítima	• Monta o regulador de pressão; • Liga tubo conector; • Insuflador manual (com balonete); • Abre a garrafa; • Seleciona o débito (10 L/min.); • Reduz o tamanho do insuflador (vítima latente); • Permeabilização da Via Aérea: - Colocação do tubo orofaríngeo – na situação de ainda não ter sido colocado. ○ Seleção – medição da distância entre a altura dos incisivos e o ângulo da mandíbula; ○ Introduzir tubo na cav. oral em posição invertida, até passar palato duro, rodar 180º, e introduzir até faringe; ○ Retirar no caso de a vítima estar reativa; ○ Após a colocação efetuar VOS. • Utiliza máscara pediátrica (ou coloca invertida a de adulto) • Faz selagem da máscara (efetua a insuflação com 1 mão)
Desmontagem do material e manutenção	• Descarta o material utilizado (máscara e tubo); • Fecha a garrafa e descarrega o sistema.

Enquadramento:

No decorrer da sua atividade enquanto NS, na **praia do Rodanho**, é abordado por **uma mulher de aproximadamente 60 anos, que manifesta ter dificuldade para respirar**. Tem disponível o Kit de Oxigénio Terapia.

Como procederia?

Definir o algoritmo/abordagem	Abordagem ABCDE (exame primário) - ligação com SBV
Avaliar condições de segurança	Avalia e garante condições de segurança
Avaliar o estado de consciência (VÍTIMA CONSCIENTE)	- Avalia o estado de consciência - Avalia como consciente - Afere que no âmbito do exame primário - ABCD já estão resolvidos (vítima está consciente, ventila e está alerta considerando a descrição)
Procedimento ABCDE (Exposição com controlo de temperatura)	Avalia como necessário proceder à administração de O2 por inalação com débito a (5 L/min.)
Montagem do material e cuidados em relação à vítima	- Monta o regulador de pressão; - Liga tubo conector; - Máscara simples ou cânulas nasais (óculos nasais); - Abre a garrafa; - Seleciona o débito (5 L/min.); - Coloca a máscara simples/cânulas nasais à vítima (acalma e informa a vítima).

Enquadramento:

O estado da vítima agrava-se, aparentando não ventilar normalmente.

Como procederia?

Definir o algoritmo	Algoritmo SBV
Avaliar condições de segurança	Avalia e garante condições de segurança (SUPRIMIR - JÁ GARANTIDO)
Avaliar o estado de consciência (NÃO RESPONDE)	- Avalia o estado de consciência - Estímulo verbal; - Estímulo tátil bilateral.
Permeabilização da Via Aérea	- Extensão da cabeça - Elevação da mandíbula
Teste de VOS (NÃO VENTILA)	- Posiciona-se corretamente; - Ver movimentos torácico-abdominais; - Ouvir o ruído do ar a entrar nas vias aéreas; - Sentir o ar expirado da vítima; - Até 10 segundos.
Não ventila / Liga 112	- Onde se encontra (localização exata) - Quem é a vítima (género e faixa etária) - O quê (o que aconteceu e estado da vítima) - Como (sabe fazer SBV e vai iniciar manobras)
Definir o método de administração de O2	Insuflação.
Montagem do material e cuidados em relação à vítima (1)	- Descarta o material utilizado (máscara ou cânula); - Liga tubo conector ao Insuflador manual (com balonete); - Seleciona o débito (15 L/min.);

Montagem do material e cuidados em relação à vítima (2)	• Permeabilização da Via Aérea: - Colocação do tubo orofaríngeo – na situação de ainda não ter sido colocado. ○ Seleção – medição da distância entre a altura dos incisivos e o ângulo da mandíbula; ○ Introduzir tubo na cav. oral em posição invertida, até passar palato duro, rodar 180º, e introduzir até faringe; ○ Retirar no caso de a vítima estar reativa; ○ Após a colocação efetuar VOS. • Faz selagem da máscara (efetua a insuflação com 1 mão).
Inicia manobras (RCP) <u>(REALIZAR 2 A 4 CICLOS DE RCP ATÉ A VÍTIMA REAGIR)</u>	• Colocação correta perante a vítima; • Coloca as mãos corretamente (centro do tórax); • Número de CTE/Insuflações (30:2); • CTE (5/6 cm; 100/120 min; tempo compressão = descompressão); • Insuflações com O2 eficazes (sem fugas, expansão visível do tórax); • Sinal de reação vítima (interrompe manobras e VOS); • Coloca vítima em PLS (objetivo permeabilização da VA).
Definir o método de administração de O2	• Inalação.
Montagem do material e cuidados em relação à vítima	• Retira o material utilizado (insuflador manual); • Liga tubo conector a uma máscara de alta concentração (composta/alto débito); • Seleciona o débito (15 L/min.); • Coloca a máscara à vítima (acalma e informa a vítima).
Desmontagem do material e manutenção	• Descarta o material utilizado (máscara e tubo); • Fecha a garrafa e descarrega o sistema.

Enquadramento:

No decorrer da sua atividade enquanto NS, na **praia da Amorosa**, é alertado para a presença de uma vítima, um **homem com aproximadamente 40 anos**, que se **encontrou em dificuldades na água e que está a ser resgatado por populares que o colocam no areal**.

Como procederia?

Definir o algoritmo	Algoritmo SBV Afogamento
Avaliar condições de segurança	Avalia e garante condições de segurança
Avaliar o estado de consciência (<u>NÃO RESPONDE</u>)	- Avalia o estado de consciência - Estímulo verbal; - Estímulo tátil bilateral.
Permeabilização da Via Aérea	- Extensão da cabeça - Elevação da mandíbula
Teste de VOS (<u>NÃO VENTILA</u>)	- Posiciona-se corretamente; - Ver movimentos torácico-abdominais; - Ouvir o ruído do ar a entrar nas vias aéreas; - Sentir o ar expirado da vítima; - Até 10 segundos.
Não ventila / Liga 112	- Onde se encontra (localização exata) - Quem é a vítima (género e faixa etária) - O quê (o que aconteceu e estado da vítima) - Como (sabe fazer SBV e vai iniciar manobras)
Não ventila	5 insuflações com O2 se possível; - Observa sinais de vida (tosse, movimento, resp. normal).
Inicia manobras (RCP) (<u>REALIZAR 2 A 4 CICLOS DE RCP ATÉ A VÍTIMA REAGIR</u>)	- Colocação correta perante a vítima; - Coloca as mãos corretamente (centro do tórax); - Número de CTE/Insuflações (30:2); - CTE (5/6 cm; 100/120 min; tempo compressão = descompressão); - Insuflações eficazes (sem fugas, expansão visível do tórax); - Sinal de reação vítima (interrompe manobras e VOS); - Coloca vítima em PLS (objetivo permeabilização da VA).

Enquadramento:

Após a vítima recuperar, ventilando normalmente, é informado por uma testemunha que a vítima sofreu uma queda aparatosa no decorrer da prática de mergulhos e acrobacias. Chega um meio complementar com o material de imobilização (colar cervical e plano rígido)

Definir o algoritmo/abordagem	Abordagem ABCDE (exame primário) - ligação com SBV
Avaliar condições de segurança	Avalia e garante condições de segurança (<u>SUPRIMIR - JÁ GARANTIDO</u>)
Avaliar a disfunção neurológica (<u>VÍTIMA NÃO REATIVA</u>)	- Avaliar a disfunção neurológica (D do exame primário - ABCDE). - Classificar a vítima na escala AVDS (A - alerta; V - alerta a estímulos verbais; D - alerta a estímulos dolorosos; S - sem resposta).
Procedimento ABCDE (<u>Exposição com controlo de temperatura</u>) (1)	- Avalia como necessário proceder à estabilização da cervical e colocação do colar cervical, seguindo-se a imobilização no plano rígido; 1.º estabilização da cabeça e da cervical, garantindo o alinhamento, nariz-umbigo-pés da vítima (1.º NS). 2.º colocação do colar cervical por o 2.º NS (necessários 2 socorristas), realizando primeiro a medição (ângulo da mandíbula-início do ombro) para selecionar o colar adequado, seguindo-se o armar do colar e a sua colocação.

Procedimento ABCDE <u>(Exposição com controlo de temperatura) (2)</u>	• 3.º posicionamento da vítima no plano rígido através da técnica de rolamento (necessários no mínimo 3 elementos, sendo ideal 4 elementos), onde: ○ a) o elemento 1 (à cabeça da vítima) coordena a tarefa e garante a estabilidade da cabeça e da cervical (alinhamento nariz-umbigo-pés) e que a vítima seja movida em bloco. ○ b) o elemento 2 (junto ao tronco da vítima) posiciona as mãos no ombro da vítima e na bacia (p. inferior) segurando a mão da vítima. ○ c) o elemento 3 (mão nível dos membros inferiores da vítima) posiciona as mãos na bacia (p. superior) e acima da articulação do joelho. ○ d) após se rodar a vítima em bloco, o elemento 4, coloca o plano rígido e acompanha o segundo rodar da vítima para se posicionar em cima do plano rígido. ○ e) correção do posicionamento, deslocando em bloco a vítima para baixo e para o centro e, para cima e para o centro, até ficar posicionada corretamente no plano rígido. • 4.º imobilização da vítima no plano rígido, colocando 1.º a cinta do tórax (atendendo à necessidade de expansão torácica da vítima), em 2.º a cinta da região pélvica, em 3.º a cinta em Y dos ombros, em 4.º a imobilização da cabeça colocando os estabilizadores laterais da cabeça, seguindo-se o imobilizador da testa e por último o imobilizador do queixo, em 5.º a cinta dos joelhos (acima da articulação) e em 6.º a cinta dos tornozelos.
---	---

Enquadramento:

Entretanto, chega o seu colega com o Kit de Oxigénio Terapia.

Definir o método de administração de O ₂	• Inalação.
Montagem do material e cuidados em relação à vítima	• Monta o regulador de pressão; • Liga tubo conector; • Máscara de alta concentração (composta/alto débito); • Abre a garrafa; • Seleciona o débito (15 L/min.); • Coloca a máscara à vítima (acalma e informa a vítima).
Desmontagem do material e manutenção	• Descarta o material utilizado (máscara e tubo); • Fecha a garrafa e descarrega o sistema.

Enquadramento:

No decorrer da sua atividade enquanto NS, na **Piscina Municipal do Atlântico — Joaquim Baptista Alves**, é alertado para a presença de uma vítima, um **homem com aproximadamente 55 anos**, que se encontra **caído no chão após uma queda**.

Como procederia?

Definir o algoritmo/abordagem	Abordagem ABCDE (exame primário) - ligação com SBV - Trauma
Avaliar condições de segurança	Avalia e garante condições de segurança
Avaliar o estado de consciência (NÃO RESPONDE)	- Avalia o estado de consciência - Estímulo verbal; - Estímulo tátil bilateral.
Permeabilização da Via Aérea	Elevação da mandíbula; ou Colocação do tubo orofaríngeo (SE POSSÍVEL).
Teste de VOS (NÃO VENTILA)	- Posiciona-se corretamente; - Ver movimentos torácico-abdominais; - Ouvir o ruído do ar a entrar nas vias aéreas; - Sentir o ar expirado da vítima; - Até 10 segundos.
Não ventila / Liga 112	- Onde se encontra (localização exata) - Quem é a vítima (género e faixa etária) - O quê (o que aconteceu e estado da vítima) - Como (sabe fazer SBV e vai iniciar manobras)
Inicia manobras (RCP) (REALIZAR 2 A 4 CICLOS DE RCP ATÉ A VÍTIMA REAGIR)	- Colocação correta perante a vítima; - Coloca as mãos corretamente (centro do tórax); - Número de CTE/Insuflações (30:2); - CTE (5/6 cm; 100/120 min; tempo compressão = descompressão); - Insuflações eficazes (sem fugas, expansão visível do tórax); - Sinal de reação vítima (interrompe manobras e VOS); Abordagem ABCDE (exame primário) – Resolvidos ABC (ligação SBV) continuar realizando: D – Avaliação da Disfunção Neurológica - Escala AVDS (A - alerta; V - alerta a estímulos verbais; D - alerta a estímulos dolorosos; S - sem resposta); E – Exposição com controlo da temperatura – observação completa e manutenção da temperatura corporal.

Enquadramento:

Após a vítima recuperar, ventilando normalmente, chega um meio complementar com o material de imobilização (colar cervical e plano rígido)

Definir o algoritmo/abordagem	Abordagem ABCDE (exame primário) - ligação com SBV
Avaliar condições de segurança	Avalia e garante condições de segurança (SUPRIMIR - JÁ GARANTIDO)
Avaliar a disfunção neurológica (VÍTIMA NÃO REATIVA)	- Avaliar a disfunção neurológica (D do exame primário - ABCDE) - (SUPRIMIR – SE JÁ REALIZADO). - Classificar a vítima na escala AVDS (A - alerta; V - alerta a estímulos verbais; D - alerta a estímulos dolorosos; S - sem resposta).
Procedimento ABCDE (Exposição com controlo de temperatura) (1)	- Avalia como necessário proceder à estabilização da cervical e colocação do colar cervical, seguindo-se a imobilização no plano rígido; 1.º estabilização da cabeça e da cervical, garantindo o alinhamento, nariz-umbigo-pés da vítima (1.º NS).

Procedimento ABCDE (<u>Exposição com controlo de temperatura</u>) (2)	• 2.º colocação do colar cervical por o 2.º NS (necessários 2 socorristas), realizando primeiro a medição (ângulo da mandíbula-início do ombro) para selecionar o colar adequado, seguindo-se o armar do colar e a sua colocação. • 3.º posicionamento da vítima no plano rígido através da técnica de rolamento (necessários no mínimo 3 elementos, sendo ideal 4 elementos), onde: ○ a) o elemento 1 (à cabeça da vítima) coordena a tarefa e garante a estabilidade da cabeça e da cervical (alinhamento nariz-umbigo-pés) e que a vítima seja movida em bloco. ○ b) o elemento 2 (junto ao tronco da vítima) posiciona as mãos no ombro da vítima e na bacia (p. inferior) segurando a mão da vítima. ○ c) o elemento 3 (mão nível dos membros inferiores da vítima) posiciona as mãos na bacia (p. superior) e acima da articulação do joelho. ○ d) após se rodar a vítima em bloco, o elemento 4, coloca o plano rígido e acompanha o segundo rodar da vítima para se posicionar em cima do plano rígido. ○ e) correção do posicionamento, deslocando em bloco a vítima para baixo e para o centro e, para cima e para o centro, até ficar posicionada corretamente no plano rígido. • 4.º imobilização da vítima no plano rígido, colocando 1.º a cinta do tórax (atendendo à necessidade de expansão torácica da vítima), em 2.º a cinta da região pélvica, em 3.º a cinta em Y dos ombros, em 4.º a imobilização da cabeça colocando os estabilizadores laterais da cabeça, seguindo-se o imobilizador da testa e por último o imobilizador do queixo, em 5.º a cinta dos joelhos (acima da articulação) e em 6.º a cinta dos tornozelos.
--	---

Enquadramento:

Entretanto, chega o seu colega com o Kit de Oxigénio Terapia.

Definir o método de administração de O ₂	• Inalação.
Montagem do material e cuidados em relação à vítima	• Monta o regulador de pressão; • Liga tubo conector; • Máscara de alta concentração (composta/alto débito); • Abre a garrafa; • Seleciona o débito (15 L/min.); • Coloca a máscara à vítima (acalma e informa a vítima).
Desmontagem do material e manutenção	• Descarta o material utilizado (máscara e tubo); • Fecha a garrafa e descarrega o sistema.

Enquadramento:

No decorrer da sua atividade enquanto NS, na **Piscina Municipal de Barroselas**, é alertado para a presença de uma vítima, uma **mulher com aproximadamente 60 anos**, que se encontra caída no chão após uma queda.

Como procederia?

Definir o algoritmo/abordagem	Abordagem ABCDE (exame primário) - ligação com SBV - Trauma
Avaliar condições de segurança	Avalia e garante condições de segurança
Avaliar o estado de consciência (NÃO RESPONDE)	- Avalia o estado de consciência - Estímulo verbal; - Estímulo tátil bilateral.
Permeabilização da Via Aérea	Elevação da mandíbula; ou Colocação do tubo orofaríngeo (SE POSSÍVEL).
Teste de VOS (NÃO VENTILA)	- Posiciona-se corretamente; - Ver movimentos torácico-abdominais; - Ouvir o ruído do ar a entrar nas vias aéreas; - Sentir o ar expirado da vítima; - Até 10 segundos.
Não ventila / Liga 112	- Onde se encontra (localização exata) - Quem é a vítima (género e faixa etária) - O quê (o que aconteceu e estado da vítima) - Como (sabe fazer SBV e vai iniciar manobras)
Inicia manobras (RCP) (REALIZAR 2 A 4 CICLOS DE RCP ATÉ A VÍTIMA REAGIR)	- Colocação correta perante a vítima; - Coloca as mãos corretamente (centro do tórax); - Número de CTE/Insuflações (30:2); - CTE (5/6 cm; 100/120 min; tempo compressão = descompressão); - Insuflações eficazes (sem fugas, expansão visível do tórax); - Sinal de reação vítima (interrompe manobras e VOS); Abordagem ABCDE (exame primário) – Resolvidos ABC (ligação SBV) continuar realizando: D – Avaliação da Disfunção Neurológica - Escala AVDS (A - alerta; V - alerta a estímulos verbais; D - alerta a estímulos dolorosos; S - sem resposta); E – Exposição com controlo da temperatura – observação completa e manutenção da temperatura corporal.

Enquadramento:

A vítima continua a não ventilar, chegando o seu colega com o Kit de Oxigénio Terapia, substituindo-o na realização do SBV. **Proceda à administração de O2.**

Definir o método de administração de O2	Insuflação.
Montagem do material e cuidados em relação à vítima	- Monta o regulador de pressão; - Liga tubo conector; - Insuflador manual (com balonete); - Abre a garrafa; - Seleciona o débito (15 L/min.); Permeabilização da Via Aérea: - Colocação do tubo orofaríngeo – na situação de ainda não ter sido colocado. - Seleção – medição da distância entre a altura dos incisivos e o ângulo da mandíbula; - Introduzir tubo na cav. oral em posição invertida, até passar palato duro, rodar 180º, e introduzir até faringe; - Retirar no caso de a vítima estar reativa; - Após a colocação efetuar VOS. - Faz selagem da máscara (efetua a insuflação com 1 mão).

Desmontagem do material e manutenção	• Descarta o material utilizado (máscara e tubo); • Fecha a garrafa e descarrega o sistema.
--------------------------------------	--

Enquadramento:

A vítima cuspiu o tubo orofaríngeo. Chega um meio complementar com o material de imobilização (colar cervical e plano rígido).

Definir o algoritmo/abordagem	• Abordagem ABCDE (exame primário) - ligação com SBV
Avaliar condições de segurança	• Avalia e garante condições de segurança (SUPRIMIR - JÁ GARANTIDO)
Teste de VOS (VENTILA)	• Posiciona-se corretamente; • Ver movimentos torácico-abdominais; • Ouvir o ruído do ar a entrar nas vias aéreas; • Sentir o ar expirado da vítima; • Até 10 segundos.
Avaliar a disfunção neurológica (VÍTIMA NÃO REATIVA)	• Avaliar a disfunção neurológica (D do exame primário - ABCDE). • Classificar a vítima na escala AVDS (A - alerta; V - alerta a estímulos verbais; D - alerta a estímulos dolorosos; S - sem resposta).
Procedimento ABCDE (Exposição com controlo de temperatura)	• Avalia como necessário proceder à estabilização da cervical e colocação do colar cervical, seguindo-se a imobilização no plano rígido; • 1.º estabilização da cabeça e da cervical, garantindo o alinhamento, nariz-umbigo-pés da vítima (1.º NS). • 2.º colocação do colar cervical por o 2.º NS (necessários 2 socorristas), realizando primeiro a medição (ângulo da mandíbula-início do ombro) para selecionar o colar adequado, seguindo-se o armar do colar e a sua colocação. • 3.º posicionamento da vítima no plano rígido através da técnica de rolamento (necessários no mínimo 3 elementos, sendo ideal 4 elementos), onde: ○ a) o elemento 1 (à cabeça da vítima) coordena a tarefa e garante a estabilidade da cabeça e da cervical (alinhamento nariz-umbigo-pés) e que a vítima seja movida em bloco. ○ b) o elemento 2 (junto ao tronco da vítima) posiciona as mãos no ombro da vítima e na bacia (p. inferior) segurando a mão da vítima. ○ c) o elemento 3 (mão nível dos membros inferiores da vítima) posiciona as mãos na bacia (p. superior) e acima da articulação do joelho. ○ d) após se rodar a vítima em bloco, o elemento 4, coloca o plano rígido e acompanha o segundo rodar da vítima para se posicionar em cima do plano rígido. ○ e) correção do posicionamento, deslocando em bloco a vítima para baixo e para o centro e, para cima e para o centro, até ficar posicionada corretamente no plano rígido. • 4.º imobilização da vítima no plano rígido, colocando 1.º a cinta do tórax (atendendo à necessidade de expansão torácica da vítima), em 2.º a cinta da região pélvica, em 3.º a cinta em Y dos ombros, em 4.º a imobilização da cabeça colocando os estabilizadores laterais da cabeça, seguindo-se o imobilizador da testa e por último o imobilizador do queixo, em 5.º a cinta dos joelhos (acima da articulação) e em 6.º a cinta dos tornozelos.

Definir método administração de O2	• Inalação.
Desmontagem do material	• retira o material utilizado (insuflador e tubo);
Montagem do material e cuidados em relação à vítima	• Liga tubo conector; • Máscara de alta concentração (composta/alto debito); • Abre a garrafa; • Seleciona o débito (15 L/min.); • Coloca a máscara à vítima (acalma e informa a vítima).
Desmontagem do material e manutenção	• Descarta o material utilizado (máscara e tubo); • Fecha a garrafa e descarrega o sistema.